



TÊN THUỐC: GOLCOXIB

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC: Mỗi viên nang cứng chứa

- Celecoxib..... 200mg
- *Tá được:* Lactose; PVP K30; Natri croscarmellose; Natri lauryl sulfat; Magnesii stearat; vđ 1 viên.

DANG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp.
- Giảm nhẹ các dấu hiệu và triệu chứng của viêm cột sống dính khớp.
- Kiểm soát đau cấp tính.
- Điều trị thống kinh nguyên phát.

CÁCH DÙNG -LIỀU DÙNG:

Viên nang Celecoxib, với liều dùng 200mg, 2 lần/ngày có thể dùng cùng thức ăn hoặc không. Các nguy cơ với tim mạch của celecoxib có thể tăng theo liều và thời gian dùng thuốc, nên dùng liều thấp nhất trong thời gian ngắn nhất có thể.

Người lớn:

- Điều trị triệu chứng trong thoái hóa khớp (OA): Liều đề nghị là 200mg dùng liều đơn tương đương 1 viên/lần/ngày hoặc 100mg, 2 lần mỗi ngày.
- Điều trị triệu chứng trong viêm khớp dạng thấp (RA): Liều đề nghị của Celecoxib là 100mg hoặc 200mg, 2 lần mỗi ngày.
- Viêm cột sống dính khớp (AS): Liều đề nghị của celecoxib là 200mg dùng liều đơn hoặc 100mg 2 lần mỗi ngày. Một số bệnh nhân có thể đạt hiệu quả điều trị tốt hơn nếu dùng 400mg/ngày.
- Kiểm soát cơn đau cấp tính: Liều đề nghị khởi đầu của celecoxib là 400mg, dùng tiếp theo với liều 200mg nếu cần trong ngày đầu tiên. Trong các ngày tiếp theo, liều đề nghị là 200mg 2 lần mỗi ngày khi cần.
- Điều trị đau bụng kinh nguyên phát: Liều đề nghị khởi đầu của celecoxib là 400mg, tiếp theo với liều bổ sung 200mg nếu cần trong ngày đầu tiên. Trong các ngày tiếp theo, liều đề nghị là 200mg 2 lần mỗi ngày khi cần.
- Những người có chuyển hóa kém CYP2C9: Những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ có chuyển hóa kém CYP2C9 dựa trên tiền sử/khíh nghiệm với các cơ chất của CYP2C9 khác cần thận trọng khi dùng celecoxib. Bắt đầu điều trị với liều 1/2 liều thấp nhất đề nghị
- Dùng kết hợp với fluconazol: Nên dùng Celecoxib với liều bằng một nửa liều khuyến cáo trên những bệnh nhân đang điều trị với fluconazol, một chất ức chế CYP2C9.

Người cao tuổi:

- Việc điều chỉnh liều dùng ở người cao tuổi nói chung không cần thiết. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân cao tuổi dưới 50kg thể trọng nên bắt đầu trị liệu ở liều khuyến cáo thấp nhất.

Cách dùng:

- Với bệnh nhân khó nuốt viên nang, có thể cho lượng thuốc trong viên vào sinh tố táo, cháo, sữa chua hoặc chuối nghiền nát để uống cùng. Khi đó, phải cho toàn bộ lượng thuốc vào một thìa nhỏ nước sinh tố táo, cháo, sữa chua hoặc chuối nghiền nát ở nhiệt độ phòng và phải uống ngay với nước. Lượng thuốc đã trộn với sinh tố táo, cháo, sữa chua có thể ổn định trong khoảng 6 giờ khi bảo quản trong tủ lạnh (2 độ C-8 độ C). Không được bảo quản thuốc với chuối nghiền nát trong tủ lạnh mà phải uống ngay.
- *Suy gan:* Liều khuyến cáo hàng ngày của GolcoXib nên giảm khoảng 50% ở bệnh nhân suy gan trung bình. Thuốc chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân suy gan nặng. Vì vậy GolcoXib được khuyến cáo là không nên sử dụng ở bệnh nhân suy gan nặng.
- *Suy thận:* Ở bệnh nhân suy thận mãn (GFR 35-60 mL/phút), AUC giảm khoảng 40% so với người có chức năng thận bình thường. Không có mối liên quan nào có ý nghĩa được tìm thấy giữa GFR và sự thanh thải celecoxib. Thuốc chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân suy thận nặng.
- *Dùng kết hợp với fluconazol:* Nên dùng Celecoxib với liều bằng một nửa liều khuyến cáo trên những bệnh nhân đang điều trị với fluconazol, một chất ức chế CYP2C9.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Celecoxib chống chỉ định đối với:

- Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với Celecoxib hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với sulfonamid.
- Các bệnh nhân có tiền sử hen, mê đay hoặc có các phản ứng kiểu dị ứng sau khi dùng acetylsalicylic acid (ASA (aspirin)) hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác (các NSAID), bao gồm các thuốc ức chế đặc hiệu cyclooxygenase-2 (COX-2) khác.
- Điều trị đau trong phẫu thuật ghép mạch động mạch vành nhân tạo (CABG) (Xem chi tiết phần Thận trọng).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Các tác động lên tim mạch:

- **Huyết khối tim mạch:** Celecoxib có thể làm tăng nguy cơ huyết khối nghiêm trọng cho tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ, là những biến cố có thể gây tử vong. Tất cả các NSAID đều có chung nguy cơ này. Nguy cơ này có thể tăng theo liều dùng, thời gian dùng và các yếu tố nguy cơ tim mạch của bản thân. Bệnh nhân với tiền sử bệnh tim mạch có thể có nguy cơ cao hơn. Để giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra tác dụng không mong muốn trên tim mạch của bệnh nhân điều trị với celecoxib, nên dùng liều ngắn nhất có hiệu quả cả trong thời gian ngắn nhất có thể. Thấy thuốc và bệnh nhân cần cảnh giác với sự phát triển của trường hợp này, ngay cả khi không có các triệu chứng về tim mạch trước đó. Bệnh nhân cần được thông báo về các dấu hiệu và triệu chứng các độc tính nghiêm trọng với tim mạch và các bước phải làm khi chúng xảy ra. 2 thứ nghiêm lâm sáng lớn, có đối chứng về một NSAID khác tác động chọn lọc trên COX-2 trong điều trị đau 10-14 ngày đầu sau khi ghép mạch động mạch vành nhân tạo (CABG) cho thấy sự tăng tỷ lệ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
- Celecoxib không phải là một thuốc thay thế cho acetylsalicylic acid trong dự phòng các bệnh tắc nghẽn huyết khối tim mạch do thiếu tác động trên chức năng tiểu cầu. Bởi vì celecoxib không ức chế kết tập tiểu cầu, không nên ngừng các trị liệu kháng tiểu cầu.
- *Cao huyết áp:* Giống như tất cả các NSAID, celecoxib có thể làm khởi phát cơn cao huyết áp hoặc làm tình trạng cao huyết áp vốn có nặng thêm, cả hai yếu tố này đều có thể làm tăng biến cố tim mạch. Nên thận trọng khi dùng các NSAID, kể cả Celecoxib trên bệnh nhân cao huyết áp. Cần theo dõi huyết áp chặt chẽ khi bắt đầu điều trị với celecoxib cũng như trong suốt thời gian điều trị.
- *Ư' dịch và phù:* Cũng như các thuốc có ức chế tổng hợp prostangladin, phù nề và ứ dịch có gặp trên bệnh nhân dùng celecoxib. Do đó cần theo dõi chặt chẽ bệnh nhân bị suy tim sung huyết hoặc cao huyết áp từ trước. Nên dùng celecoxib thận trọng cho các bệnh nhân tổn thương chức năng tim, phù hoặc các tình trạng có thể trở nên trầm trọng hơn do ứ dịch và phù bao gồm những người dùng thuốc lợi tiểu, hoặc có nguy cơ giảm thể tích máu.

Các tác động trên đường tiêu hóa:

- **Thủng đường tiêu hóa trên và dưới, loét hoặc chảy máu đã xảy ra với những bệnh nhân dùng celecoxib.** Những bệnh nhân có nguy cơ cao nhất bị những biến chứng này trên đường tiêu hóa khi dùng NSAID bao gồm: Người cao tuổi, bệnh nhân bị các bệnh tim mạch, bệnh nhân đang dùng aspirin, các glucocorticoid hoặc NSAID khác, bệnh nhân dùng thức uống có cồn hoặc bệnh nhân có tiền sử hoặc đang bị các bệnh đường tiêu hóa tiến triển như loét, các tình trạng như chảy máu hoặc viêm đường tiêu hóa. Hầu hết các báo cáo ngẫu nhiên về các trường hợp tử vong do biến cố trên đường tiêu hóa có liên quan đến celecoxib là trên các bệnh nhân về chất yếu hoặc người cao tuổi.

Các tác động trên thận:

- Các NSAID bao gồm celecoxib có thể gây độc trên thận. Các thử nghiệm lâm sàng với celecoxib đã chỉ ra các tác động tương tự như với các NSAID khác được so sánh. Bệnh nhân có nguy cơ nhiễm độc thận cao nhất là những bệnh nhân suy chức năng thận, suy tim, suy chức năng gan và người cao tuổi. Cần theo dõi cẩn thận những bệnh nhân này khi điều trị bằng celecoxib.
- Cần thận trọng khi điều trị cho những bệnh nhân mất nước. Trước tiên cần bù nước cho bệnh nhân rồi mới điều trị bằng celecoxib.

Bệnh thận tiến triển:

- Cần theo dõi chặt chẽ chức năng thận ở bệnh nhân bị bệnh thận tiến triển đang dùng celecoxib.

Phản ứng phụ vệt:

- Cũng như các thuốc NSAID nói chung, các phản ứng phân vệt đã xảy ra trên các bệnh nhân dùng celecoxib.

Các phản ứng nghiêm trọng trên da:

- Các phản ứng nghiêm trọng trên da, một số phản ứng dẫn đến tử vong, bao gồm viêm da tróc vảy, hội chứng Steven-johnson, và hội tự biểu bì nhiễm độc, đã được báo cáo nhưng rất hiếm gặp khi dùng celecoxib. Bệnh nhân thường có nguy cơ cao với các biến cố này trong giai đoạn sớm của quá trình điều trị, các trường hợp này xảy ra thường trong vòng đầu tiên của quá trình điều trị. Cần ngưng sử dụng celecoxib ngay khi xuất hiện mẩn đỏ da, tổn thương niêm mạc hoặc bất cứ dấu hiệu quá mẫn nào.

Các tác động trên gan:

- Chưa có nghiên cứu trên bệnh nhân suy gan nặng. Không sử dụng celecoxib trên bệnh nhân suy gan nặng. Celecoxib cần được sử dụng thận trọng trên các bệnh nhân suy gan vừa và nên bắt đầu với liều bằng một nửa liều khuyến cáo.
- **Hiếm gặp các tác dụng không mong muốn trên gan, bao gồm viêm gan kịch phát (một số trường hợp gây tử vong), hoại tử gan và suy gan (một số trường hợp gây tử vong hoặc cần phải ghép gan) đã được báo cáo với celecoxib.**
- Bệnh nhân có các triệu chứng và/hoặc dấu hiệu của suy gan hoặc người có xét nghiệm chức năng gan bất thường cần được theo dõi chặt chẽ về các dấu hiệu phát triển phản ứng trên gan trầm trọng hơn quá trình điều trị với celecoxib.

Sử dụng thuốc chống đông máu đường uống:

- Việc sử dụng đồng thời các NSAID với thuốc chống đông máu đường uống làm tăng nguy cơ xuất huyết và cần được sử dụng thận trọng. Các thuốc chống đông máu đường uống bao gồm các thuốc dạng wafarin/coumarin và các thuốc chống đông máu đường uống thế hệ mới (ví dụ: Apixaban, dabigatran và rivaroxaban). Đã có báo cáo về trường hợp chảy máu nghiêm trọng trên các bệnh nhân đang dùng đồng thời với wafarin hoặc các chất tương tự, trong đó có một số trường hợp đã gây tử vong. Do đó có báo cáo về tăng thời gian prothrombin (INR), tác dụng chống đông/INR cần được theo dõi ở bệnh nhân dùng thuốc chống đông dạng wafarin/coumarin hoặc chỉnh liều sau khi bắt đầu điều trị bằng celecoxib.

Tổng quan:

- Với tác dụng chống viêm, celecoxib làm mờ đi các dấu hiệu chẩn đoán, ví dụ như triệu chứng sốt trong chẩn đoán nhiễm trùng.
- Cần tránh dùng đồng thời celecoxib với một thuốc NSAID không phải aspirin.

Ức chế CYP2D6:

- Celecoxib cho thấy khả năng ức chế CYP2D6 ở mức trung bình. Đối với những thuốc được chuyển hóa bởi CYP2D6, có thể cần phải giảm liều trong thời gian bắt đầu điều trị bằng celecoxib hoặc tăng khi ngưng điều trị bằng celecoxib.
- Sản phẩm có chứa lactose thận trọng sử dụng cho người không dung nạp lactose.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:

Ảnh hưởng trên khả năng sinh sản:

- Dựa trên cơ sở hoạt động, việc sử dụng các NSAID, kể cả celecoxib có thể gây trì hoãn hoặc ngăn cản sự rụng trứng, liên quan đến hiện tượng vô sinh có thể phục hồi ở một số phụ nữ. Những phụ nữ khó thụ thai hay đang chờ vô sinh, cần cân nhắc việc ngưng dùng các NSAID, bao gồm cả celecoxib.

Phụ nữ có thai:

- Chưa có nghiên cứu trên phụ nữ có thai. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy độc tính trên sinh sản. Chưa có các dữ liệu trong tương đương trên người.
- Celecoxib, cũng như các thuốc ức chế tổng hợp prostangladin khác, có thể gây vô lực cơ tử cung và đông sớng ống động mạch chủ, không nên dùng celecoxib vào 3 tháng cuối thai kỳ.
- Chỉ nên dùng celecoxib khi mang thai nếu lợi ích đối với người mẹ vượt trội nguy cơ tiềm tàng đối với thai nhi.
- **Ức chế tổng hợp prostangladin có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho phụ nữ mang thai.** Dù liệu từ các nghiên cứu dịch tễ cho thấy nguy cơ xảy thai tự phát tăng lên sau khi dùng các thuốc ức chế tổng hợp prostangladin trong giai đoạn sớm của thai kỳ. Dùng các thuốc ức chế tổng hợp prostangladin trên động vật cho thấy nguy cơ xảy thai tăng lên ở giai đoạn trước và sau khi làm phẫu.

Phụ nữ cho con bú:

- Nghiên cứu trên chuột cho thấy celecoxib được bài tiết qua sữa với nồng độ tương đương nồng độ trong huyết tương. Trên phụ nữ cho con bú dùng celecoxib, rất ít celecoxib xuất hiện trong sữa. Vì thế có thể có tác dụng không mong muốn của celecoxib trên trẻ đang bú mẹ, tùy theo lợi ích và nguy cơ của người mẹ, nên cân nhắc ngừng thuốc hoặc ngừng cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- Chưa có nghiên cứu về tác động của celecoxib trên khả năng lái xe và vận hành máy móc nhưng dựa trên các đặc tính dược lý học và mô tả tổng quát về an toàn, có thể không có ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Tổng quan:

- Celecoxib chủ yếu chuyển hóa qua cytochrom P450 (CYP) 2C9 tại gan. Cần thận trọng khi dùng celecoxib trên bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ chuyển hóa qua CYP2C9 kém dựa trên tiền sử với các cơ chất khác của CYP2C9 vì nồng độ thuốc trong huyết tương có thể cao bất thường do giảm độ thanh thải chuyển hóa. Nên bắt đầu điều trị với liều bằng 1 nửa liều đề nghị.
- Việc sử dụng đồng thời celecoxib với các chất ức chế CYP2C9 có thể dẫn đến việc tăng nồng độ celecoxib trong huyết tương. Vì vậy, có thể cần giảm liều celecoxib khi celecoxib được dùng đồng thời với các chất ức chế CYP2C9.
- Việc sử dụng đồng thời celecoxib với các chất cảm ứng CYP2C9 như rifampicin, carbamazepin và barbiturat có thể dẫn đến việc giảm nồng độ celecoxib trong huyết tương. Vì vậy, cần tăng liều celecoxib khi celecoxib được dùng đồng thời với các chất cảm ứng CYP2C9.
- Nghiên cứu ức chế động học và nghiên cứu in vitro cho thấy mặc dù celecoxib không phải là cơ chất nhưng nó là chất ức chế CYP2D9. Do đó có thể có tương tác thuốc in vivo giữa celecoxib với thuốc chuyển hóa bởi CYP2D9.

Với các thuốc cụ thể:

- **Tương tác giữa celecoxib và wafarin (Xem phần Chống chỉ định: Sử dụng với thuốc chống đông máu đường uống).**
- **Lithium:** Ở đối tượng khỏe mạnh, nồng độ lithium trong huyết tương tăng khoảng 17% khi dùng đồng thời Lithium với celecoxib. Cần theo dõi chặt chẽ bệnh nhân đang điều trị lithium khi dùng celecoxib hoặc ngưng dùng celecoxib.
- **Aspirin:** Celecoxib không ảnh hưởng đến tác động kháng tiểu cầu của aspirin liều thấp. Vì không có tác động trên tiểu cầu, celecoxib không phải là chất thay thế cho aspirin trong điều trị dự phòng bệnh tim mạch.
- **Các thuốc chống tăng huyết áp bao gồm các chất ức chế men chuyển angiotensin (ACEI), chất đối kháng angiotensin II (ARB), các thuốc lợi tiểu và các thuốc chẹn Beta:** Việc ức chế prostangladin có thể làm giảm tác dụng của các thuốc chống tăng huyết áp bao gồm ACEI và/hoặc ARB, thuốc lợi tiểu, thuốc chẹn Beta. Cần lưu ý tương tác này khi dùng đồng thời celecoxib với ACEI và/hoặc ARB, thuốc lợi tiểu và thuốc chẹn beta.
- **Đối với bệnh nhân cao tuổi, bị giảm thể dịch (bao gồm cả người đang dùng thuốc lợi tiểu) hoặc bị tổn thương chức năng thận, việc dùng đồng thời các thuốc NSAID, bao gồm các thuốc ức chế chọn lọc COX-2 với thuốc ức chế men chuyển angiotensin, các chất đối kháng angiotensin, II hoặc thuốc lợi tiểu có thể dẫn đến tổn hại chức năng thận bao gồm cả suy thận cấp tính. Các tác dụng này thường là có thể phục hồi. Vì vậy cần thận trọng khi sử dụng đồng thời các thuốc này. Cần cho bệnh nhân uống nước đầy đủ và vệ mặt lâm sàng cần theo dõi, đánh giá chức năng thận khi bắt đầu điều trị kết hợp và đánh giá theo định kỳ sau đó.**
- **Kết quả từ nghiên cứu lisinopril:** Trong nghiên cứu lâm sàng kéo dài 28 ngày ở bệnh nhân cao huyết áp giai đoạn I và II đối chứng bằng lisinopril, kết quả của việc sử dụng celecoxib 200mg 2 lần mỗi ngày cho thấy huyết áp tâm thu hoặc huyết áp tâm trương trung bình giảm ngay, được xác định bằng phương pháp theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ, không tăng có ý nghĩa về mặt lâm sàng khi so sánh với điều trị bằng giả được. Trong những bệnh nhân đồng thời sử dụng celecoxib 200mg 2 lần mỗi ngày, 48% được xem là không đáp ứng với lisinopril vào lần thăm khám cuối cùng (nghĩa là huyết áp tâm trương >90mmHg hoặc huyết áp tâm trương tăng >10% so với mức cơ sở), so với 27% ở bệnh nhân sử dụng đồng thời với giả được, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê.
- **Cyclosporin:** do tác dụng trên prostangladin thận, các NSAID có thể làm tăng nguy cơ nhiễm độc thận do cyclosporin.
- **Fluconazol và ketoconazol:** Dùng đồng thời fluconazol liều 200mg, 1 lần/ngày làm tăng gấp đôi nồng độ celecoxib trong huyết tương. Việc tăng lên này do tác động ức chế chuyển hóa của celecoxib qua CYP2C9 bởi fluconazol. Celecoxib nên được sử dụng với liều bằng một nửa liều khuyến cáo ở bệnh nhân đang dùng fluconazol, chất ức chế CYP2C9. Ketoconazol, một chất ức chế CYP3A4, không có tác dụng ức chế chuyển hóa celecoxib đáng kể trên lâm sàng.
- **Dextromethorphan và metoprolol:** Sử dụng đồng thời celecoxib 200mg 2 lần mỗi ngày dẫn đến việc tăng lần lượt 2,6 lần và 1,5 lần nồng độ dextromethorphan và metoprolol trong huyết tương (cơ chất của CYP2D6). Việc tăng lên này là do sự ức chế của celecoxib lên sự chuyển hóa cơ chất của CYP2D6 qua CYP2D6. Vì vậy có thể cần giảm liều lượng của các thuốc là cơ chất của CYP2D6 khi bắt đầu điều trị bằng celecoxib hoặc tăng liều khi ngưng điều trị bằng celecoxib.
- **Thuốc lợi tiểu:** Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy trên một số bệnh nhân, NSAID có thể làm giảm tác dụng thải natri qua nước tiểu của furosemid và thiazid bằng cách ức chế tổng hợp prostangladin.
- **Methotrexat:** Không quan sát thấy tương tác được động học và lâm sàng quan trọng nào trong nghiên cứu lâm sàng giữa celecoxib và methotrexat.
- **Các thuốc tránh thai đường uống:** Trong một nghiên cứu tương tác, celecoxib không có tác dụng rõ ràng trên lâm sàng với lợi được động học của thuốc tránh thai đường uống kết hợp (1mg norethindron/0.035 mg ethinyl estradiol).
- **Các thuốc khác:** Chưa có báo cáo tương tác quan trọng nào về mặt lâm sàng giữa celecoxib và thuốc kháng acid (nhôm và magnesii), omeprazol, glibenclamid (glyburid), phenytoin hoặc toltetamid.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- **Diễn biến trong các thử nghiệm lâm sàng.**
- Các tác dụng không mong muốn (ADR) dưới đây được báo cáo với tỉ lệ lớn hơn 0.01% ở nhóm dùng celecoxib và cao hơn so với báo cáo của nhóm dùng giả được trong 12 thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả được và/hoặc với hoạt chất khác, kéo dài tới 12 tuần, liều dùng hàng ngày từ 100mg đến 800mg ở người lớn. Tần suất của các ADR dưới đây được báo cáo nhất từ trên dữ liệu tổng hợp từ 89 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng mô tả việc sử dụng trên lâm sàng ở 31802 bệnh nhân dùng celecoxib. Tần suất ADR được định nghĩa như sau: Rất thường gặp (>10%), thường gặp (≥ 1% và <10%), ít gặp (≥ 0.1% và <1%), hiếm gặp (>0.01% và <0.1%), rất hiếm gặp (<0.01%). Các ADR được liệt kê theo hệ cơ quan và xếp theo thứ tự tần suất giảm dần.

Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR) trong 12 thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả dược và/hoặc với hoạt chất khác, và tần suất ADR từ 89 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng về đau và viêm với liều hàng ngày từ 25mg-800mg ở nhóm đối tượng trưởng thành:

Nhiễm trùng

- *Thường gặp*: Viêm phế quản, viêm xoang, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
- *Ít gặp*: Viêm họng, viêm mũi.

Rối loạn hệ máu và bạch cầu

- *Ít gặp*: Thiếu máu.
- *Hiếm gặp*: Giảm tiểu cầu.

Rối loạn hệ miễn dịch

- *Ít gặp*: Quá mẫn.

Rối loạn tâm thần

- *Thường gặp*: Mắt ngủ.
- *Ít gặp*: Lo lắng.
- *Hiếm gặp*: Trạng thái lú lẫn.

Rối loạn thần kinh

- *Thường gặp*: Chóng mặt.
- *Ít gặp*: Tăng trương lực cơ, buồn ngủ.

Rối loạn mắt

- *Ít gặp*: Nhìn mờ.

Rối loạn tai và tai trong

- *Không thường gặp*: ù tai.

Rối loạn tim

- *Ít gặp*: Tim đập nhanh.
- *Hiếm gặp*: Suy tim sung huyết, loạn nhịp, nhịp tim nhanh.

Rối loạn mạch

- *Thường gặp*: Tăng huyết áp (bao gồm cả cao huyết áp nặng hơn)
- *Hiếm gặp*: Đò mặt.

Rối loạn hô hấp, vùng ngực và trung thất

- *Thường gặp*: Ho.

Rối loạn tiêu hóa

- *Thường gặp*: Nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, đầy bụng.
- *Ít gặp*: Loét dạ dày, rối loạn về răng.
- *Hiếm gặp*: Loét tá tràng, loét thực quản.
- *Rất hiếm gặp*: Thủng ruột, viêm tụy.

Rối loạn gan mật

- *Ít gặp*: Men gan tăng (bao gồm cả tăng alanin aminotransferase và tăng aspartat aminotransferase).

Rối loạn da và mô dưới da

- *Thường gặp*: Ngứa (bao gồm cả ngứa toàn thân), phát ban.
- *Ít gặp*: Mày đay, bầm máu.
- *Hiếm gặp*: Phù mạch, rụng tóc.
- *Rất hiếm gặp*: Viêm da bong nước.

Rối loạn toàn thân và tại chỗ

- *Thường gặp*: Phù ngoại biên.
- *Ít gặp*: Phù mắt, bệnh giống cúm.

Tôn thương, nhiễm độc và tình trạng do thủ thuật

- *Ít gặp*: Tôn thương.

Các phản ứng bất lợi của thuốc thêm vào dưới đây được báo cáo với tỉ lệ xảy ra lớn hơn với giả dược trong nghiên cứu phòng ngừa polyp kéo dài tới 3 năm với liều hàng ngày từ 400mg đến 800mg.

Tác dụng không mong muốn của thuốc trong nghiên cứu phòng ngừa polyp kéo dài tới 3 năm với liều hàng ngày từ 400mg-800mg:

Nhiễm trùng

- *Thường gặp*: Nhiễm khuẩn tai, nhiễm nấm**.
- *Ít gặp*: Nhiễm Helicobacter, Herpes zoster, viêm quầng, nhiễm khuẩn vết thương, viêm lợi, viêm tai trong, nhiễm khuẩn.

U tân sinh lành tính, ác tính chưa phân loại:

- *Ít gặp*: U mô.

Rối loạn tâm thần

- *Ít gặp*: Rối loạn giấc ngủ.

Rối loạn hệ thần kinh

- *Ít gặp*: Nhồi máu não.

Rối loạn mắt

- *Ít gặp*: Xuất huyết kết mạc, thấy đốm đen bay trước mắt (vitreous floaters)

Rối loạn tai và tai trong

- *Ít gặp*: Giảm thính lực.

Rối loạn tim

- *Thường gặp*: Nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực.
- *Ít gặp*: Đau thắt ngực thể không ổn định, thiếu năng van động mạch, xơ vữa động mạch vành, nhịp tim chậm xoang, phì đại tâm thất.

Rối loạn mạch

- *Rất thường gặp*: Tăng huyết áp*.
- *Ít gặp*: Huyết khối tĩnh mạch sâu, ụ máu.

Rối loạn hô hấp, vùng ngực và trung thất

- *Thường gặp*: Khó thở.
- *Ít gặp*: Khó phát âm.

Rối loạn tiêu hóa

- *Rất thường gặp*: Tiêu chảy*.
- *Thường gặp*: Nôn mửa, khó nuốt, hội chứng ruột kích thích, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, buồn nôn, ch ỉ nang.
- *Ít gặp*: Trĩ xuất huyết, ruột co bóp thường xuyên, loét miệng, viêm dạ dày.

Rối loạn gan mật

- *Thường gặp*: Men gan tăng (bao gồm cả tăng alanin aminotransferase và tăng aspartat aminotransferase).

Rối loạn da và mô dưới da

- *Ít gặp*: Viêm da dị ứng.

Rối loạn cơ xương và mô liên kết

- *Thường gặp*: Co thắt cơ.
- *Ít gặp*: U nang bao hoạt dịch.

Rối loạn thận và tiết niệu

- *Thường gặp*: Sỏi thận.
- *Ít gặp*: Đi tiểu đêm.

Rối loạn tuyến vú và hệ sinh sản

- *Thường gặp*: Xuất huyết âm đạo, viêm tiền liệt tuyến, tăng sản tiền liệt tuyến lành tính.
- *Ít gặp*: Nang buồng trứng, các triệu chứng tắt kinh, căng ngực, thống kinh.

Rối loạn toàn thân và tại chỗ

- *Ít gặp*: Phù.

Thăm khám

- *Thường gặp*: Tăng cường creatinin máu, tăng kháng nguyên đặc hiệu tiền liệt, tăng triglycerid.
- *Ít gặp*: Tăng kali máu, tăng natri máu giảm testosterone nam, giảm tỉ lệ hồng cầu, tăng hemoglobin.

Tôn thương, nhiễm độc và các biến chứng do thủ thuật

- *Ít gặp*: Gãy bàn chân, gãy chi dưới, gãy xương, viêm môm gò xương, đứt gân.

* Tăng huyết áp, nôn mửa, tiêu chảy và tăng men gan được liệt kê vì có tần suất cao hơn trong các nghiên cứu kéo dài tới 3 năm, bao gồm những tác dụng không mong muốn trong các nghiên cứu chỉ kéo dài 12 tuần.

** Nhiễm nấm tại chỗ ban đầu.

Kính nghiệm sử dụng sau khi đưa thuốc ra thị trường

- Các tác dụng không mong muốn xác định được sau khi đưa thuốc ra thị trường được trình bày dưới đây. Mặc dù các tác dụng này được xác định từ các báo cáo sau lưu hành, dữ liệu thử nghiệm đã được tham khảo để ước tính tần suất. Như đã nêu ở trên, tần suất được dựa trên các tập hợp các thử nghiệm mô tả việc dùng thuốc trên 31802 bệnh nhân. Tần suất được định nghĩa như sau: Rất thường gặp ($\geq 10\%$), thường gặp ($\geq 1\%$ và $<10\%$), ít gặp ($\geq 0.1\%$ và $<1\%$), hiếm gặp ($\geq 0.01\%$ và $<0.1\%$), rất hiếm gặp ($<0.01\%$), không rõ (không thể ước lượng từ dữ liệu có sẵn).
- Rối loạn hệ miễn dịch: Rất hiếm gặp: Phản ứng phản vệ.
- Rối loạn tâm thần: Hiếm gặp: Áo giác.
- Rối loạn hệ thần kinh: Xuất huyết não, viêm màng não vô khuẩn, mất vị giác, mất khứu giác.
- Rối loạn mắt: Ít gặp: Viêm kết mạc.
- Rối loạn mạch: Rất hiếm gặp: Viêm mạch.
- Rối loạn hô hấp, vùng ngực và trung thất: Hiếm gặp: Nghẽn mạch phổi, viêm phổi.
- Rối loạn tiêu hóa: Hiếm gặp: Xuất huyết tiêu hóa.
- Rối loạn gan mật: Hiếm gặp: Viêm gan. Rất hiếm gặp: Suy gan, viêm gan kịch phát, hoại tử gan, ứ mật, viêm gan tắc mật, bệnh vàng da.

- Rối loạn da và mô dưới da: Hiếm gặp: Phản ứng nhạy cảm với ánh sáng. Rất hiếm gặp: Hội chứng Steven-Johnson, hồng ban đa dạng, hoại tử biểu bì nhiễm độc, phản ứng do thuốc kèm theo tăng bạch cầu ưa eosin và triệu chứng toàn thân (DRESS hoặc hội chứng quá mẫn), ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP), viêm da tróc vảy.
- Rối loạn thận và tiết niệu: Hiếm gặp: Suy thận cấp, giảm natri máu. Rất hiếm gặp: Viêm thận kẽ hội chứng thận hư, viêm cầu thận sang thương tối thiểu.
- Rối loạn tuyến vú và hệ sinh sản: Hiếm gặp: Rối loạn kinh nguyệt. Chưa xác định được: Rối loạn khả năng sinh sản ở nữ giới (bệnh giảm khả năng sinh sản ở nữ giới).
- Rối loạn toàn thân và tại chỗ: Ít gặp: Đau ngực.
- Phụ nữ có ý định mang thai được loại khỏi tất cả các nghiên cứu, do đó tham khảo cơ sở dữ liệu thử nghiệm về tần suất của trường hợp này là không hợp lý.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Kính nghiệm lâm sàng về tình trạng quá liều còn hạn chế. Dùng liều đơn 1200mg hoặc đa liều với tổng liều là 1200mg/ngày trên người khỏe mạnh không cho thấy tác dụng không mong muốn nào có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Trong trường hợp nghi ngờ quá liều, nên có các biện pháp hỗ trợ về y tế thích hợp. Thẩm phân máu không phải là biện pháp hiệu quả để loại bỏ thuốc vì thuốc liên kết chặt chẽ với protein.

ĐẠC TÍNH ĐƯỢC LỰC HỌC:

- Nhóm trị liệu: M01AH Coxibs.
- Cơ chế tác dụng của Celecoxib là ức chế tổng hợp Prostaglandin chủ yếu bằng cách ức chế cyclooxygenase-2 (COX-2). Ở nồng độ điều trị trên người, celecoxib không ức chế enzym cyclooxygenase-1 (COX-1). COX-2 được tạo ra nhằm đáp ứng với tác nhân gây viêm. Điều này dẫn đến việc tổng hợp và tích lũy các prostanooid gây viêm, đặc biệt là prostaglandin E2, gây viêm, phù nề và đau. Celecoxib tác dụng như một chất kháng viêm giảm đau và hạ nhiệt trên các mô hình động vật do ngăn cản các quá trình sản xuất các prostanooid gây viêm thông qua ức chế COX-2. Trong các mô hình u ruột kết ở động vật, celecoxib giảm tỉ lệ và sự nhân lên của các khối u.
- Các nghiên cứu in vivo và ex-vivo cho thấy celecoxib có ái lực rất thấp với enzym COX-1. Vì vậy, ở liều điều trị, celecoxib không có tác dụng trên các prostanooid được tổng hợp do kích hoạt COX-1, do đó, không ảnh hưởng tới các quá trình sinh lý bình thường liên quan đến COX-1 ở mô, đặc biệt với da dày, ruột và tiêu cầu.

ĐẠC TÍNH ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

Hấp thu:

- Dược động học của celecoxib đã được đánh giá trên khoảng 1500 người. Khi dùng lúc đói, celecoxib dễ dàng được hấp thu và đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương sau khoảng 2-3 giờ. Sinh khả dụng đường uống dạng viên nang là 99% so với dạng hỗn dịch (dạng uống tối ưu hiện có). Khi dùng trong lúc đói cả nồng độ đỉnh trong huyết tương (Cmax) và diện tích dưới đường cong (AUC) đều tỉ lệ với liều cho đến 200mg, 2 lần/ngày; Ở liều cao hơn tỉ lệ tương ứng của Cmax và AUC thấp hơn.

Phân bố:

- Tỷ lệ gắn kết với protein huyết tương (tỷ lệ này không phụ thuộc nồng độ) là khoảng 97% ở nồng độ điều trị trong huyết tương và celecoxib không ưu tiên gắn với hồng cầu.

Chuyển hóa:

- Celecoxib được chuyển hóa chủ yếu qua cytochrom P450 2C9. Ba sản phẩm chuyển hóa không có tác dụng ức chế COX-1 hoặc COX-2 được nhận diện trong huyết thanh người là alcol bậc nhất, acid carboxylic tương ứng và liên hợp glucuronid của nó.
- Hoạt tính của cytochrom P450 2C9 giảm ở người có đa hình di truyền và điều này dẫn đến giảm hoạt tính enzym, ví dụ người đồng hợp tử với đa hình CYP2C9*3.
- Trong nghiên cứu được động học với celecoxib 200mg dùng 1 lần/ngày ở người tình nguyện khỏe mạnh, kiểu gen là CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 hoặc CYP2C9*3/*3, giá trị trung bình của Cmax và AUC₀₋₂₄ của celecoxib vào ngày 7 lần lượt là xấp xỉ gấp 4 lần và 7 lần, ở những người có kiểu gen CYP2C9*3/*3 so với các kiểu gen. Trong 3 nghiên cứu đơn liều riêng rẽ, có tổng cộng 5 đối tượng có kiểu gen CYP2C9*3/*3, giá trị AUC₀₋₂₄ của liều đơn tăng khoảng 3 lần so với những người chuyển hóa bình thường. Ước tính tần suất xuất hiện kiểu gen *3/*3 là 0.3% đến 1.0% ở các nhóm dân tộc khác nhau.
- Bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ có chuyển hóa CYP2C9 kém dựa trên tiền sử/kinh nghiệm với các cơ chất khác nhau của CYP2C9 nên thận trọng khi dùng celecoxib. Nên xem xét việc điều trị với một nửa liều để nghi thấp nhất.

Thải trừ:

- Celecoxib thải trừ chủ yếu do chuyển hóa qua gan với dưới 1% liều dùng được bài tiết nguyên dạng qua nước tiểu. Sau khi dùng đa liều, thời gian bán thải là từ 8-12 giờ và tốc độ thanh thải khoảng 500ml/phút. Với đa liều, nồng độ thuốc trong huyết tương đạt mức ổn định trước ngày thứ 5. Biến thiên giữa các đối tượng ở các thông số được động học (AUC, Cmax, thời gian bán thải) là khoảng 30%. Thời thải phân bổ ở trạng thái ổn định trung bình khoảng 500L/70kg ở người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy sự phân bố rộng khắp của celecoxib vào các mô. Các nghiên cứu tiền lâm sàng đã xác định được thuốc qua được hàng rào máu não.

Ảnh hưởng của thức ăn

- Dùng thuốc cùng thức ăn (giàu chất béo) làm chậm sự hấp thu của celecoxib thể hiện qua Tmax đạt được sau khoảng 4 giờ và làm sinh khả dụng tăng khoảng 20%.
- Ở người tình nguyện khỏe mạnh, lượng hấp thu toàn thân (AUC) của celecoxib tương đương của dạng uống nguyên viên nang hoặc dạng hòa tan trong nước sốt táo. Không có sự thay đổi có ý nghĩa về Cmax, Tmax hoặc T1/2 sau khi uống thuốc nguyên viên hoặc hòa tan vào nước sốt táo.

Các nhóm bệnh nhân đặc biệt

Người cao tuổi:

- Ở người trên 65 tuổi, giá trị trung bình Cmax và AUC của celecoxib tăng lên 1.5-2 lần. Điều này chủ yếu liên quan đến cân nặng chứ không phải do thay đổi về tuổi tác, celecoxib có nồng độ cao hơn trên những bệnh nhân có cân nặng ít hơn và do đó cao hơn ở những người lớn tuổi có cân nặng trung bình thấp hơn những người trẻ. Do vậy, phụ nữ lớn tuổi có xu hướng có nồng độ thuốc trong huyết tương cao hơn đàn ông lớn tuổi. Nói chung không cần điều chỉnh liều. Tuy nhiên, với các bệnh nhân lớn tuổi có cân nặng dưới trung bình (<50kg), nên bắt đầu điều trị bằng liều đủ nguy hiểm có hoạt tính.

Chung tộc

- Một phân tích tổng hợp các nghiên cứu được động học đã dự đoán AUC của celecoxib ở người da đen cao hơn khoảng 40% so với người da trắng. Nguyên nhân và ý nghĩa lâm sàng của vấn đề này vẫn chưa được biết.

Suy gan

- Nồng độ trong huyết tương của celecoxib ở bệnh nhân suy gan nhẹ không có khác biệt nào đáng kể so với nồng độ ở nhóm đối chứng có tuổi và giới tính tương ứng. Trên các bệnh nhân suy gan vừa nồng độ celecoxib trong huyết tương cao hơn khoảng 2 lần so với nhóm đối chứng tương ứng.

Suy thận

- Trên các bệnh nhân tình nguyện cao tuổi bị giảm tốc độ lọc cầu thận (GFR) do tuổi (GFR trung bình >65ml/phút/1,73m2) và các bệnh nhân suy thận mạn ổn định (GFR 35-60 ml/phút/1.73 m2) được động học của celecoxib được so sánh với các bệnh nhân có chức năng thận bình thường. Không có mối liên hệ đáng kể nào được tìm thấy giữa creatinin huyết thanh (hoặc hệ số thanh thải creatinin) và độ thanh thải celecoxib. Suy thận nặng không làm thay đổi độ thanh thải celecoxib do đường thải trừ chính của thuốc là qua chuyển hóa qua gan dưới dạng không có hoạt tính.

Ảnh hưởng trên thận

- Các vai trò liên quan của COX-1 và COX-2 trong sinh lý thận chưa được biết đầy đủ. Celecoxib làm giảm sự thải trừ qua thận của PEG₃ và 6-keto PGF₁α (một chất chuyển hóa của prostacyclin) nhưng không ảnh hưởng đến thải trừ thromboxan B2 huyết thanh và 11-dehydro-TXB₂, một chất chuyển hóa của thromboxan (cả hai đều là sản phẩm của COX-1). Các nghiên cứu đặc thù đã cho thấy celecoxib không làm giảm GFR ở bệnh nhân lớn tuổi hoặc bệnh nhân suy thận mạn. Các nghiên cứu này cũng cho thấy sự giảm bài tiết natri tạm thời. Trong các nghiên cứu trên bệnh nhân viêm khớp, đã quan sát thấy tỷ lệ phù mạch ngoại vi tương đương so với bệnh nhân ức chế COX không đặc hiệu (cũng có tác động ức chế COX-2). Điều này thấy rõ nhất trên những bệnh nhân đang điều trị kết hợp với thuốc lợi tiểu. Tuy nhiên không ghi nhận tăng tỉ lệ tăng huyết áp và suy tim; Phù mạch ngoại vi thường nhẹ và tự hết.

QUY CÁCH CHẾ ĐÓNG GIỚI: Hộp 3 vi x 10 viên; Hộp 10 vi x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên.

BẢO QUẢN:Bảo quản thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Lượng thuốc hòa tan trong nước sinh tố táo, cháo, sữa chua, ổn định trong tối đa 6h khi bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C). Không được bảo quản lượng thuốc trộn lẫn trong chuối, nghiền nát trong tủ lạnh mà phải uống ngay.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

MEDISUN

Công ty sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

(Thành viên của Sohaco Group)

Địa chỉ: Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3589036 – Fax: 0274 3589297

SCHACO
Group

Công ty đăng ký và phân phối: Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm và Thương Mại SOHACO

Địa chỉ: Số 5, Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: 0246.664.4567

Fax: 0246.664.6226